

Hindi Makontrol na Pagtae (Fecal Incontinence)

WARWIKI

Impormasyon para sa Pasyente · Pagtagas ng hangin o dumi — karaniwan at maaaring gamutin

Ang hindi makontrol na pagtae (pagtagas ng dumi) ay ang hindi mapigilang paglabas ng hangin o dumi — nagtatagas bago pa makarating sa banyo, o nang hindi namamalayan. Ito ay mas karaniwan kaysa sa iniisip ng marami, lalo na pagkatapos ng panganganak o dahil sa edad, at ito ay maaaring gamutin. Walang dapat ikahiya, at ang pagsasabi sa inyong care team ang unang hakbang tungo sa paggaling.

Tungkol sa Kondisyong Ito

Ang kontrol ng dumi ay nakasalalay sa **mga kalamnan ng anal sphincter**, ang pelvic floor, ang konsistensiya ng dumi, at ang mga nerbiyos na nag-uugnay sa lahat ng ito. Ang problema sa alinman sa mga ito ay maaaring magdulot ng pagtagas — mula sa bahagyang mantsa at hangin hanggang sa buong dumi.

Mga Sanhi

- **Pinsala sa sphincter** — madalas dahil sa malalim na punit sa panganganak o nakaraang operasyon sa puwit
- **Malambot na dumi o pagtatae** — mas mahirap pigilin kaysa sa matigas na dumi
- **Matinding konstipasyon** (paninigas ng dumi) na may pagtagas sa paligid ng matigas na dumi
- **Problema sa nerbiyos**, pagbaba ng tumbong (rectal prolapse), o irritable bowel

Kadalasan, maraming salik ang kasangkot, at marami sa mga ito ay maaaring mapabuti.

MGA TERMINO

Fecal incontinence

Hindi sinasadyang paglabas ng hangin o dumi.

Anal sphincter

Bilog na kalamnan na nagtataglay ng dumi hanggang handa kang pumunta sa banyo.

OASIS

Malalim na punit sa panganganak (3rd/4th-degree) na nakaapekto sa sphincter.

Fiber

Sustansiya na nagpapatibay ng malambot na dumi at nagbabawas ng pagtagas.

Biofeedback

Therapy na muling nagsasanay sa mga kalamnan ng pelvic floor at sphincter.

Sacral neuromodulation

Paggamot sa pamamagitan ng nerve stimulation para mapabuti ang kontrol.

MAY EPEKTIBONG LUNAS BA DITO? Oo — karamihan sa mga pasyente ay lubos na gumagaling, madalas sa pamamagitan ng simpleng hakbang tulad ng pagpatibay ng dumi at pagsasanay sa mga kalamnan. Ang mas advanced na mga opsyon ay epektibo rin kung kinakailangan. Ang pinakamahirap na bahagi ay ang pagsasabi nito; kapag nagawa mo na, malinaw ang landas tungo sa mas magandang kontrol.

Paano Ito Nasusuri

- Kasaysayan kung gaano kadalas, gaano karami, at ano ang nagdudulot ng pagtagas
- Pagsusuri ng anal sphincter at pelvic floor
- Minsan, ultrasound ng sphincter, anorectal testing, o scope

Paano Ito Ginagamot (Hakbang-hakbang)

- 1 **Kontrol ng dumi** — dagdag ng fiber para patibaying ang dumi, gamutin ang pagtatae o konstipasyon, at magtakda ng regular na oras ng pagdumi.
- 2 **Pelvic floor therapy / biofeedback** para palakasin at i-coordinate ang mga kalamnan.
- 3 **Mga gamot** (tulad ng anti-diarrheal) kapag malambot ang dumi.
- 4 **Mga advanced na opsyon** — sacral neuromodulation, injectable bulking agent, o pag-aayos ng sphincter.

Pamumuhay Dito

- Layunin ang **maayos na hugis ng dumi** sa pamamagitan ng fiber at sapat na likido.
- Dumumi sa regular na oras; pangalagaan ang balat at magdala ng supplies para sa kumpiyansa.
- Subaybayan kung aling pagkain ang nagpapalala ng pagtagas (kape, maanghang, artificial sweeteners).

Tawagan ang inyong care team kung kayo ay may:

- **Dugo sa dumi**, o itim at malapot na dumi
- Bagong o malaking pagbabago sa gawi ng pagdumi, o biglaang pagbaba ng timbang
- Lagnat o matinding sakit sa tiyan

TATLONG BAGAY NA DAPAT TANDAAN

1. Ang hindi makontrol na pagtae ay karaniwan at maaaring gamutin — hindi kailangan tiisin o itago.
2. Nagsisimula ang paggamot sa pagpatibay ng dumi at pagsasanay sa mga kalamnan, pagkatapos ay may mas advanced na opsyon kung kinakailangan.
3. Sabihin sa inyong care team — ito ang pangunahing hakbang. Iulat ang dugo sa dumi, pagbaba ng timbang, o malaking pagbabago sa gawi ng pagdumi.